

TEMA 8.6 • NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA

Cefalea, Tumor Cerebral y Hemorragia Subaracnoidea

PERFIL EUNACOM 1.10.1.011

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Síndromes Motores y Sensitivos: Polineuropatías, Guillain-Barré, Miastenia

Miopatías vs. Polineuropatías

TABLA 8.6.1: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS			
MIOPATÍAS		POLINEUROPATÍAS	
Debilidad	Proximal (hombros, caderas)	Distal (pies, manos)	
Sensibilidad	Normal	Alterada (guante y calcetín)	
Atrofia	Leve o hipertrofia	Marcada , distal	

Polineuropatía

- **Causa más frecuente: diabetes** (neuropatía diabética)
- Otras: déficit de B12, B1, autoinmune, genética (Charcot-Marie)

Clínica

- **Hipostesia** distal (termalgésica, vibratoria, propioceptiva)
- **Debilidad** distal (motora)
- **Dolor neuropático**: urente + alodinia (dolor al roce) + hiperalgesia
- Distribución "en guante y calcetín"

Tratamiento

- Tratar la causa (control glicémico, vitaminas)
- Cuidado de los pies (riesgo pie diabético)
- Dolor neuropático: gabapentina / pregabalina / amitriptilina

Neuropatías por Atrapamiento

TABLA 8.6.2: NEUROPATÍA VS NERVIIO				
NEUROPATÍA	NERVIIO	CLÍNICA	ASOCIACIÓN	TRATAMIENTO
Túnel carpiano	Mediano	Parestesias/debilidad dedos 1-4 (mitad radial del 4º)	Embarazo, DM, AR, HTA	Cirugía por liberación del retináculo
Atrapamiento cubital	Cubital	Parestesias/debilidad dedos 4-5 (mitad cubital del 4º)	Apoyo en codo	Cirugía
Meralgia parestésica	Femorocutáneo lateral	Cara lateral del muslo	Obesidad	EMG + cirugía o tratar causa

Estudio: electromiografía (EMG) — muestra alteración de conducción solo en zona atrapada.

Parálisis por compresión

TABLA 8.6.3: NOMBRE VS NERVIIO AFECTADO			
NOMBRE	NERVIIO AFECTADO	CAUSA	CLÍNICA
Parálisis del borracho	Radial	Se duerme sobre el brazo	No extiende muñeca ni dedos; ↓ reflejo tricipital
Parálisis de luna de miel	Plexo braquial	La pareja se duerme sobre el hombro	Extremidad superior "muerta" (motor + sensitivo)

Miopatías Inflammatorias

TABLA 8.6.4: MIOPATÍA VS CLÍNICA	
MIOPATÍA	CLÍNICA
Polimiositis	Debilidad proximal + ↑ CPK + sin rash
Dermatomiositis	Ídem + rash: heliotropo periorbitario, pápulas de Gottron
Polimialgia reumática	Dolor proximal sin debilidad real; ↑ VHS; adulto mayor

Miastenia Gravis vs. Lambert-Eaton

TABLA 8.6.5: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS		
	MIASTENIA GRAVIS	LAMBERT-EATON
Anticuerpos	Anti-receptor nicotínico de ACh	Anti-canales de calcio presinápticos
Debilidad con repetición	Empeora	Mejora
Sistema autónomo	No afecta	Sí (alteraciones pupilares, esfínteres)
Tumor asociado	Tímoma	Cáncer de pulmón células pequeñas
Diagnóstico	Test tensilon + EMG + Anti-AChR	EMG + Anti-VGCC

Síndrome de Guillain-Barré (SGB)

- **Causa:** desmielinización del **SNP** (≠ EM que es SNC)
- **Desencadenante:** infección previa (más frecuente: **Campylobacter** por diarrea)

Clínica:

- - **Tetraparesia flácida arreflexica** (ascendente)
- - Hipostesia + dolor
- - **Parálisis facial bilateral** (VII par)
- - Riesgo de parálisis frénica → insuficiencia respiratoria

Exámenes

TABLA 8.6.6: EXAMEN VS HALLAZGO	
EXAMEN	HALLAZGO
EMG	Enlentecimiento de conducción difuso
Punción lumbar	Disociación albúmino-citológica (↑ proteínas, células normales)

Tratamiento

- Soporte ventilatorio (si insuficiencia respiratoria)
- **Plasmaféresis** o **inmunoglobulina G** en altas dosis (ambas equivalentes)

Diagnóstico diferencial

TABLA 8.6.7: ENTIDAD VS DIFERENCIA DE SGB	
ENTIDAD	DIFERENCIA DE SGB
Botulismo	Solo motor; lactante < 1 año + ingesta de miel; afecta a varios simultáneos
Poliomielitis	Erradicada; solo en paciente inmunodeprimido post-vacuna oral
Mielitis transversa	Nivel sensitivo definido + compromiso esfínteres + dolor dorsal; origen autoinmune

Mielitis Transversa

- **Causa:** autoinmune (LES, Sjögren)
- **Clínica:** síndrome de "sección medular" → desde el nivel hacia abajo:
 - - Paraparesia o tetraparesia
 - - **Nivel sensitivo** (clave diagnóstica)
 - - Compromiso esfínteres (vejiga, recto)
 - - Dolor dorsal (meningismo local)
- **Diagnóstico:** RNM médula espinal
- **Tratamiento:** corticoides EV

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 45 años presenta cefalea de inicio súbito, intensidad 10/10, que describe como 'el peor dolor de cabeza de su vida', asociada a vómitos. No tiene signos focales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta inmediata?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Cefalea, Tumor Cerebral y Hemorragia Subaracnoidea. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Cefalea súbita + máxima intensidad (10/10) = sospechar hemorragia subaracnoidea → TAC sin contraste.
- Diferencia clave: hemorragia subaracnoidea NO tiene signos focales (tiene signos meníngeos tardíos). AVE hemorrágico SÍ tiene signos focales.
- TAC sin contraste para procesos vasculares/traumáticos. TAC con contraste para procesos tumorales/infecciosos.
- Hemorragia subaracnoidea con TAC normal pero clínica sugerente → punción lumbar buscando GR crenados o xantocromía.
- Tratamiento hemorragia subaracnoidea: manejo igual a AVE hemorrágico + neurocirugía para cerrar aneurisma + nimodipino (previene vasoespasma) por 3 semanas.
- Tumor cerebral: tríada de hipertensión endocraneana + signos focales + convulsiones focales, con cefalea PROGRESIVA (no súbita). Estudio con RM o TAC con contraste.
- Hipertensión endocraneana: cefalea holocránea matinal + náuseas/vómitos + edema de papila. Neuroimagen normal + PL con HTE = pseudotumor cerebri → acetazolamida.
- Absceso cerebral = igual que tumor pero con FIEBRE.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CEFALEA, TUMOR CEREBRAL Y HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA)**PREGUNTA 1**

Paciente de 45 años presenta cefalea de inicio súbito, intensidad 10/10, que describe como 'el peor dolor de cabeza de su vida', asociada a vómitos. No tiene signos focales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta inmediata?

- A)** Migraña severa; iniciar triptanes endovenosos
- B)** Hemorragia subaracnoidea; TAC de cerebro sin contraste
- C)** AVE hemorrágico; TAC de cerebro sin contraste
- D)** Meningitis bacteriana; punción lumbar urgente
- E)** Tumor cerebral; resonancia magnética con contraste

PREGUNTA 2

Paciente con clínica altamente sugerente de hemorragia subaracnoidea (cefalea súbita 10/10 hace 8 horas). Se realiza TAC de cerebro que resulta normal. ¿Cuál es la conducta?

- A)** Dar de alta con analgésicos, el TAC descarta la hemorragia
- B)** Realizar punción lumbar buscando glóbulos rojos crenados o xantocromía
- C)** Repetir el TAC en 24 horas
- D)** Solicitar resonancia magnética urgente
- E)** Solicitar angiografía cerebral

PREGUNTA 3

Paciente de 55 años presenta cefalea progresiva de 2 meses, que ha ido aumentando de intensidad, asociada a hemiparesia derecha y una convulsión focal del brazo derecho. ¿Cuál es el estudio de elección?

- A)** TAC de cerebro sin contraste
- B)** Electroencefalograma
- C)** Resonancia magnética de cerebro o TAC con contraste
- D)** Punción lumbar
- E)** Angiografía cerebral

RESUMEN: CEFALEA, TUMOR CEREBRAL Y HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

Esta clase aborda el enfrentamiento general de las cefaleas, enfatizando la identificación de signos de alarma para diferenciar causas graves de benignas. Si no hay signos de alarma, el manejo es sintomático. Si los hay, se requiere neuroimagen y manejo específico. Se revisan las cefaleas según etiología: hemorragia subaracnoidea (cefalea súbita, máxima intensidad, signos de hipertensión endocraneana, signos meníngeos tardíos), AVE hemorrágico (súbito/rápido con signos focales), meningitis bacteriana aguda (fiebre + signos meníngeos), tumor cerebral (cefalea progresiva + hipertensión endocraneana + signos focales + convulsiones focales) y absceso cerebral (igual que tumor pero con fiebre). El síndrome de hipertensión endocraneana presenta cefalea holocránea matinal, náuseas/vómitos y edema de papila. La conducta es neuroimagen. Si TAC/RM normales pero punción lumbar confirma hipertensión, es hipertensión endocraneana idiopática (pseudotumor cerebri), que se trata con acetazolamida y diuréticos. La hemorragia subaracnoidea se diagnostica con TAC sin contraste; si este es normal pero la clínica es sugerente, se hace punción lumbar buscando glóbulos rojos crenados o xantocromía. El tratamiento incluye manejo igual al AVE hemorrágico, cirugía para cerrar el aneurisma y nimodipino para prevenir vasoespasmo. El tumor cerebral se estudia con RM o TAC con contraste.